ONEMA-POP-037 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-037 — Reconhecimento do Processo Ativo de Morte,

Conforto e Fluxo Seguro no Óbito Domiciliar

1. Identificação institucional

983558 | Data: 09/11/2026.

2. Objetivo e abrangência

Padronizar reconhecimento do processo ativo de morte, conforto e fluxo seguro no óbito domiciliar na atuação da rede ONEMA ONE, com avaliação, execução segura, continuidade e escalonamento. Aplicável ao atendimento domiciliar e, quando pertinente, digital; não substitui decisões médicas nem suporte de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Execução e julgamento clínico por enfermeiro habilitado, conforme competências e treinamento. Indicações: Pessoa com

doença avançada e suspeita de processo ativo de morte, com plano de cuidados; não substitui constatação médica do óbito. Contraindicações operacionais: ausência de consentimento ou de condições seguras, urgência incompatível com atendimento eletivo, ou ação fora da competência/prescrição.

4. Materiais, equipamentos e fornecimento

Enfermeiro: materiais de avaliação, higiene e conforto; paciente: plano antecipado, contatos de referência e documentos

assistenciais. Em visitas presenciais, o profissional dispõe de aparelho de pressão validado, estetoscópio, termômetro e oxímetro; utilizar conforme avaliação. Insumos específicos são providenciados pelo paciente/responsável, salvo acordo contratual.

5. Avaliação clínica e preparo

Declínio funcional, consciência, ingestão, respiração, perfusão, sintomas, preferências e disponibilidade de cuidador. Confirmar identidade, consentimento, privacidade, ambiente e plano prévio; estabelecer linha de base e reconhecer urgências antes de iniciar.

6. Execução técnica numerada

1. Verificar identidade, diagnóstico, trajetória recente e plano antecipado de cuidados.

2. Avaliar sinais compatíveis com últimos dias de vida, reconhecendo incerteza prognóstica.

3. Identificar sintomas tratáveis: dor, dispneia, agitação, secreções, retenção urinária e sofrimento familiar.

4. Priorizar higiene oral, posicionamento, privacidade, presença de pessoas desejadas e conforto.

5. Confirmar com equipe médica revisão de medicações e via de administração; não suspender ou prescrever

autonomamente.

6. Comunicar mudança de condição à equipe e aos familiares autorizados, respeitando preferências do paciente.

7. Diante de aparente óbito, seguir fluxo local de acionamento do médico/serviço competente para constatação e

documentação; não emitir declaração de óbito.

8. Registrar cronologia, sinais observados, contatos, orientações, decisões e destino do caso.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Morte súbita inesperada, suspeita de violência, causa externa ou ausência de plano paliativo: acionar serviços

competentes e preservar condições conforme orientação; não tratar como óbito esperado. Em emergência, acionar SAMU

192 e registrar horário e destinatário; não retardar atendimento por registro digital.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar família sobre contatos, suporte emocional e trâmites somente após confirmação pelos profissionais competentes.

Confirmar compreensão por retorno verbal e definir quem será contatado em caso de piora.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa, histórico e avaliação, sinais vitais pertinentes, diagnósticos

e plano de Enfermagem, passos executados e não executados com justificativa, resposta clínica, intercorrências,

orientações, contatos e encaminhamentos, profissional responsável e assinatura/trilha de auditoria.

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

 NICE NG31 — Care of dying adults in the last days of life —

https://www.nice.org.uk/guidance/ng31/chapter/Recommendations

 OMS — Palliative care, fact sheet — https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care

 COFEN, Resolução nº 736/2024 — Processo de Enfermagem —

https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/